NUTRICIÓN APLICADA A TERAPIA FISICA

Medidas antropométricas

Semana 11

Presente.

Docente:

Mg. Lic. Henry Donayre Hilario

Saberes previos:

¿Qué entendemos por medidas antropométricas en nutrición?

OBSERVA EL VIDEO

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de la herramienta digital:

https://www.youtube.com/watch?v=QL4mfkU5bqo

¿Cuáles son las características de las medidas antropométricas?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las medidas antropometricas mediante un organizador visual.

Temario:

1. Conceptos básicos
2. Clasificación
3. Complicaciones
4. Referencia bibliograficas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS

PROPOSITO

el propósito general de esta exposición es contribuir a mejorar la calidad de atención de los servicios de salud en las áreas de Control de Crecimiento y Programas de Complementación Alimentaria, mediante la capacitación del personal de salud en la obtención de las medidas antropométricas

OBJETIVOS:

- **Dotar al personal que trabaja en los servicios de salud de conocimientos, habilidades y destrezas para mejorar la toma de las medidas antropométricas.**

- **Capacitar al personal de salud que trabaja en el área de alimentación y nutrición en el registro de datos**

- **Contribuir a establecer en las Subregiones de Salud un equipo técnico especializado en la supervisión y estandarización de las medidas antropométricas y registro de datos.**

DEFINICION:

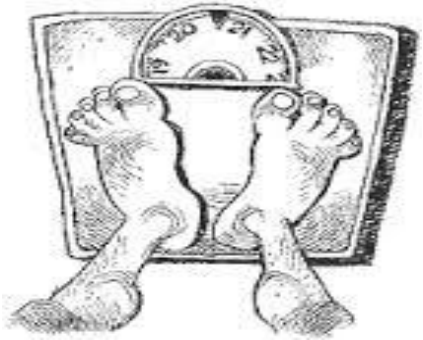
Método para evaluar el crecimiento físico (las proporciones, talla y composición del cuerpo humano), lo cual refleja el estado de salud y nutrición de una población o individuo.

PESO

Expresa el crecimiento de la masa corporal en su conjunto. Para evaluar el peso adecuadamente debemos tener en cuenta la edad del niño, la talla, la complexión del cuerpo, constitución física de los padres, entre otros

INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL PESO

Balanza de palanca y no de resorte.
Balanza para RN y lactantes divisiones de lectura c/50g o menos; en niños mayores lecturas c/100g o menos.



REQUISITOS PARA MEDIR EL PESO

Desnudos
no consumo de alimentos previo
equipo de alimentos previo
haber calibrado la pesa
Haber calibrado miccionado y defecado

TÉCNICA PARA MEDIR EL PESO

- **Pesar sin ropa**
- **Colocar niño sobre centro de plataforma o bandeja de balanza Efectuándose lectura con el vástago en el centro de su recorrido, hasta los 10 ó 100g completos.**
- **ejemplo: si vástago está entre los 18.700g y los 18.800g la lectura será de 18.70 g.**

MEDICIÓN ERRÓNEA PESO - CORPORAL

Juguetes
zapatos
medias
pañal
Relojes
Gorras
accesorios

VALORE DE REFERENCIA PARA EL PESO

RECIEN NACIDO 2500 - 3500
1 mes 750 gr
2 meses 750 gr
3 meses 750 gr
4 meses 750 gr
5 meses 500 gr
6 meses 500 gr
7 meses 500 gr
8 meses 500 gr
9 meses 250 gr
10 meses 250 gr
11 meses 250 gr
12 meses 250 gr
2 años 12 kg
3 – 10 años Formula edad x 2 + 8

	CHICOS		CHICAS	
EDAD	PESO	TALLA	PESO	TALLA
Recién nacido	3,47	50,06	3,34	49,34
3 meses	6,26	60,44	5,79	59,18
6 meses	8,02	66,81	7,44	65,33
9 meses	9,24	71,1	8,03	69,52
1 año	10,15	75,08	9,60	73,55
2 años	12,70	86,68	12,15	85,4
3 años	14,84	94,62	14,10	93,93
4 años	16,90	102,11	15,15	101,33
5 años	19,06	109,11	17,55	108,07
6 años	21,40	115,4	20,14	114,41
7 años	23,26	120,40	23,27	120,54
8 años	25,64	126,18	26,80	126,52
9 años	28,60	131,71	30,62	132,40
10 años	32,22	136,53	34,61	138,11
11 años	36,51	141,53	38,65	142,98
12 años	41,38	146,23	42,63	149,03
13 años	46,68	156,05	46,43	154,14
14 años	52,15	160,92	49,92	157,88
15 años	57,49	168,21	53	160,01
16 años	62,27	171,40	55,54	160,68
17 años	66,03	173,23	57,43	160,72
18 años	68,19	174,10	58,55	160,78

LA TALLA

DEFINICION:
Es la dimensión que mide la altura de todo el cuerpo; se le considera la dimensión más útil para la evaluación del crecimiento.
LONGITUD CORPORAL EN DECÚBITOSUPINO

INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA TALLA

Debe medirse hasta los 2-3 años (colaboración). Cualquiera sea debe reunir las siguientes condiciones:

Superficie horizontal dura.

Una superficie vertical

Regla o cinta métrica móvil que se desplace inextensible graduada en horizontalmente milímetros a lo largo, manteniendo un ángulo recto

TECNICA PARA MEDIR LA TALLA

Es necesario un ayudante.
Colocar niño en decúbito supino sobre 1 superficie horizontal plana
EL Ayudante mantiene cabeza en contacto con extremo cefálico de dicha superficie
El observador estira piernas y mantiene pies en ángulo recto, deslizando superficie vertical móvil hasta que esté firmemente en contacto con talones del niño, efectuándose entonces la lectura.

VALORES DE REFERENCIA DE LA TALLA

RECIEN NACIDO 48 -52 cm
1 mes 4 cm
2 meses 4 cm
3 meses 3 cm
4 meses 3 cm
5 meses 2 cm
6 meses 2 cm
7 meses 2 cm
8 meses 2 cm
9 meses 1 cm
10 meses 1 cm
11 meses 1 cm
12 meses 1 cm
2 años 85 cm
3 años 95 cm
4 años 1 metro
5 años 5 cm x año
6 años 5 cm x año
7 años 5 cm x año
8 años 5 cm x año=120 cm
9 años 3 – 4 cm x año
10 años 3 – 4 cm x año

PERÍMETRO CEFÁLICO

es la medición de la circunferencia extrema de la cabeza tambien es la Evaluación indirecta de la masa cerebral Desarrollo neurológico Parámetro normal 37cm

El PC puede disminuir aprox. 0.5 cm Recien nacidos: • A término: ganancia promedio de 0.5 cm /semana durante los primeros 3 meses • Prematuro: 0.1 – 0.6cm /semana. OJO • Hidrocefalia: ganancia > 1.25cm/semana • Microcefalia: ganancia mínima o nula. PC al nacer: 35 cm (prom)

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL PC

TÉCNICA

Ejercer leve Inicio (0cm)Cabeza libre de presión para ubicado en la todo objeto comprimir cabello y la piel del Bebé sostenido.

Se compara con Cinta en plano por otro la tabla de horizontal observador percentiles O punto de referencia: Cinta métrica

PERÍMETRO TORÁCICO

Monitoreo de la acreción del tejido adiposo Permite clasificar riesgo de morbi-mortalidad.

Es la medida de la circunferencia del tórax
Parámetro normal: (neonato 33ª 36.5cm)

INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL PT

TECNICA PARA MEDIR EL PT

No ejercer la Lectura al final más mínima posición erecta perpendicular a brazos a los tronco costados

CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO

es la medida de la circunferencia del brazo EXPREZADA EN CENTIMETROS SIRVE PARA CONCOER EL ESTADO DE NUTRICION DEL PACIENTE.

Es un indicador de reserva calórica y proteica, ya que refleja tanto el contenido de grasa como de musculo.

TECNICA PARA MEDIR LA CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO

Se usa el miembro izquierdo manteniéndolo colgado libremente y en la distancia media entre acromion y olécranon.

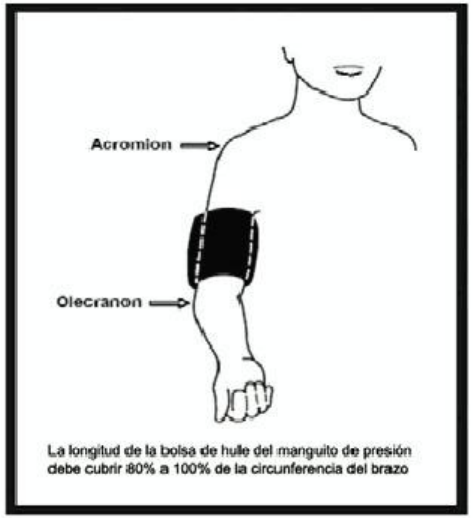


Figura 5. Determinación del tamaño del manguito de presión. Paso 2.

Figura 4. Determinación del tamaño del manguito de presión. Paso 1.

CONCLUCIONES

El análisis de algunas variables antropométricas como el peso y la talla, y de los indicadores derivadas de ellas, utilizados, bien sea individualmente o en poblaciones, son un excelente instrumento para evaluar, el crecimiento, desarrollo, maduracion y estado nutricional de los niños y adolecentes. Resaltando que son herramientas fáciles y económicas que pueden ser utilizadas tanto por el especialista, como los padres y maestros, ya que es de suma importancia llevar un registro y seguimiento de todos estos indicadores.

recomendaciones

La habitación destinada al estudio antropométrico debe ser amplia y con regulación de temperatura para hacerla confortable al estudiado.
El estudiado estará descalzo y con la menor ropa posible (pantalón corto o bañador de 2 piezas).
Los instrumentos de medida serán calibrados antes de comenzar la toma de medidas antropométricas.
Antes de comenzar la medición se marcarán, con lápiz dermográfico, los puntos anatómicos que servirán de referencia para la toma posterior de medidas.

Consultas:

Realizaremos un mapa mental de forma grupal sobre las medidas antropométricas en recién nacidos vs adultos mayores

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Referencias bibliográficas:

- Martínez Costa C, Pedrón Giner C. (2018). Valoración del estado nutricional. AEP.
- Naranjo Castillo A, Alcívar Cruz V. (2020) Desnutrición infantil Kwashiorkor. Recimundo.
- Alonso Álvarez M, Alonso Franch M. (2007) Manual practico de nutrición en pediatría
- Lázaro Almarza A, Meavilla Olivas S. (2018). Déficit de vitaminas y oligoelementos. AEP.
- Moreno Aznar L. Obesidad. AEP.
- Marquez Gonzalez H (2012). Clasificación y evaluación de la desnutriciónen el paciente pediátrico.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.